



# Actualización sobre los trastornos de la conducta alimentaria

M.A. Álvarez-Mon<sup>a,b,\*</sup>, F. Mora<sup>a,c</sup>, A. Rodríguez-Quiroga<sup>a,c</sup> y J. Quintero<sup>a,c</sup>

<sup>a</sup>Servicio de Psiquiatría y Salud Mental. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid. España. <sup>b</sup>Departamento de Medicina y Especialidades Médicas.

Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Madrid. España. <sup>c</sup>Departamento de Medicina Legal y Psiquiatría. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. España.

## Palabras Clave:

- Anorexia nerviosa
- Bulimia nerviosa
- Trastorno por atracón
- Trastornos de la conducta alimentaria

## Keywords:

- Anorexia nervosa
- Bulimia nervosa
- Binge eating disorder
- Eating disorders

## Resumen

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) (sobre todo la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracones) comienzan principalmente en la adolescencia y la juventud, y se caracterizan por: restricción de las calorías, cantidad y/o tipo de alimentos, atracones recurrentes y conductas compensatorias que conducen a un estado de malnutrición. Además, presentan una preocupación exagerada por su peso e imagen corporal. Los TCA tienden a las recaídas. Es fundamental hacer un abordaje terapéutico multidisciplinar. El uso de psicofármacos en la anorexia nerviosa estaría limitado a formas clínicas de intensidad grave o para el tratamiento de los trastornos comórbidos. En la bulimia nerviosa estaría indicado el uso de fluoxetina, sobre todo asociada a la psicoterapia cognitiva conductual y a la intervención familiar. Las comorbilidades psiquiátricas son habituales (trastornos de ansiedad, episodios depresivos, abuso de sustancias o riesgo de suicidio). El diagnóstico es clínico, por lo que la principal herramienta es la entrevista clínica, pero también es necesaria una valoración médico-nutricional.

## Abstract

### Update on eating disorders

Eating disorders (ED) (mainly anorexia, bulimia, and binge eating disorder) mainly start in adolescence and youth. They are characterized by restriction of calories and/or food types, recurrent binges, and compensatory behaviors that lead to a state of malnutrition. Patients also present with an exaggerated preoccupation with their weight and body image. ED tend to entail relapses. A multidisciplinary treatment approach is fundamental. The use of psychotropic drugs in anorexia nervosa would be limited to clinical forms of severe intensity or for the treatment of comorbid disorders. In bulimia nervosa, it would be limited to the use of fluoxetine and, most of all, associated with cognitive behavioral psychotherapy and family intervention. Psychiatric comorbidities are common (anxiety disorders, depressive episodes, substance abuse, or risk of suicide). The diagnosis is clinical and thus the main tool is a clinical interview, but a medical-nutritional evaluation is also necessary.

## Anorexia nerviosa

### Definición

La anorexia nerviosa (AN) se manifiesta como un deseo irrefrenable de estar delgado, acompañado de la práctica voluntaria de procedimientos para conseguirlo como la dieta restric-

tiva y/o las conductas purgativas. A pesar de la pérdida de peso progresiva, las personas afectadas continúan presentando un intenso temor a llegar a ser obesas<sup>1</sup>. Presentan una distorsión de la imagen corporal, con una precaución extrema por la dieta, la figura y el peso, persistiendo en conductas de evitación de la comida, con acciones compensatorias para contrarrestar lo que ingieren como la hiperactividad física desmesurada, los vómitos autoinducidos, el abuso de laxantes o el uso de diuréticos<sup>2</sup>. No suelen tener conciencia de enfermedad ni del riesgo que corren por su conducta, centrando exclusivamente su atención en la pérdida ponderal, lo que les causa estados nutricionales carenciales que comportan riesgos vitales<sup>3</sup>.

\*Correspondencia

Correo electrónico: maalvarezdemon@icloud.com

## Epidemiología

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son más frecuentes en mujeres que en hombres<sup>4</sup>. La prevalencia a lo largo de la vida de la AN es del 1,4% para mujeres y del 0,2% para hombres<sup>5</sup>. En entornos clínicos, la proporción de mujeres/hombres varía de 10:1 a 20:1. Se ha señalado que los TCA se encuentran entre las 10 causas más frecuentes de incapacidad entre mujeres, y que poseen el índice de mortalidad más alto de todos los trastornos mentales<sup>4</sup>.

La AN suele empezar durante la adolescencia o la edad adulta temprana<sup>6</sup>. Las edades de inicio más habituales se sitúan entre los 14 y los 18 años, pero hasta el 5% de los pacientes se inicia a principios de la década de los 20 años. Rara vez empieza antes de la pubertad o después de los 40 años. El inicio de este trastorno se suele asociar con un acontecimiento vital estresante<sup>6</sup>. Aunque inicialmente se describió una frecuencia más elevada entre las clases sociales superiores, los estudios epidemiológicos recientes no muestran una distribución similar. Si parece ser más habitual en los países desarrollados.

## Etiología y factores de riesgo

En las causas de la AN intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales. A nivel biológico, concretamente en la posible etiología genética, algunas pruebas indican unas tasas de concordancia más elevadas entre gemelos monocigóticos que entre los dicigóticos. Además, las hermanas de pacientes con AN tienen una mayor probabilidad de presentar la enfermedad, aunque esta asociación puede ser más un reflejo de influencias sociales que de factores genéticos. Se han descrito a nivel neurobiológico un conjunto de anomalías cerebrales en la AN a través de técnicas de imagen funcionales (imágenes de resonancia magnética —RM— funcional y tomografía por emisión de positrones —PET—)<sup>6</sup>, como un hipometabolismo tanto a nivel global como en determinadas áreas cerebrales, entre las que se encuentran la corteza frontal y parietal, el giro cingulado anterior, el tálamo y la amígdala-hipocampo<sup>4</sup>. No obstante, no está claro hasta qué punto estos hallazgos reflejan anomalías primarias asociadas al trastorno o son alteraciones secundarias de la desnutrición<sup>6</sup>. A nivel psicológico, las personas que desarrollan trastornos de ansiedad o muestran rasgos obsesivos en la infancia tienen mayor riesgo de desarrollar AN. Además, el perfeccionismo o la baja autoestima son factores de riesgo para la AN<sup>4</sup>. Por último, en relación con las variables sociales y ambientales, la preocupación excesiva por el peso o los antecedentes de haber hecho dieta parecen indicar un mayor riesgo de desarrollo de AN<sup>7</sup>. En la sociedad occidental el deseo de estar delgado es dominante, y más del 50% de las niñas en edad prepuberal hacen dieta o adoptan otras medidas para controlar su peso<sup>8</sup>. De hecho, algunos antecedentes comunes en la AN son la preocupación excesiva por el peso, la obsesión por un cuerpo delgado, el estrés sociofamiliar, el antecedente de haber realizado una dieta y el de abuso sexual en la infancia<sup>8</sup>. La AN puede observarse con mayor frecuencia entre mujeres jóvenes con profesiones que exigen delgadez como la moda o la danza.

## Cuadro clínico y diagnóstico

Lo primero que puede llamar nuestra atención al realizar la historia clínica a una persona con AN es que, pese al frecuente estado de desnutrición que presenta y la impresión de gravedad que transmite, no suele tener conciencia de enfermedad y acude a la consulta con escasa voluntad de cooperación<sup>9</sup>. A nivel sintomático, la AN es un síndrome caracterizado por presentar síntomas a tres niveles:

1. A nivel psicopatológico, con una búsqueda implacable de la delgadez y un miedo intenso a la obesidad que, además, suele asociarse con una distorsión de la imagen corporal.
2. A nivel del comportamiento, con una inanición auto-inducida de una intensidad significativa.
3. A nivel fisiológico, con la presencia de signos y síntomas médicos debidos a la inanición.

En la tabla 1 se recogen los principales criterios para el diagnóstico de la AN<sup>6,10</sup>. Es interesante destacar que el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales en su 5ª edición (DSM-5) realiza una serie de cambios con respecto a su edición anterior, el DSM-IV-TR, que pretenden me-

TABLA 1

### Criterios diagnósticos de la anorexia y la bulimia nerviosas (DSM-5)

| Anorexia nerviosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bulimia nerviosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Restricción de la ingesta</b> de energía en relación con las necesidades, lo que lleva a un <b>peso corporal significativamente bajo</b> para la edad, sexo, etapa de desarrollo y salud física del paciente. Un peso significativamente bajo se define como un peso que es <b>inferior al mínimo normal o</b>, en niños y adolescentes, inferior al mínimo esperado</p> <p><b>Miedo intenso a ganar peso</b> o engordar, o comportamiento persistente que interfiere con el aumento de peso, incluso con un peso significativamente bajo</p> <p><b>Alteración en la forma en que experimenta el peso o la constitución</b>, influencia indebida del peso corporal o la constitución corporal en la autoevaluación, o falta persistente de reconocimiento de la gravedad del bajo peso corporal actual</p> <p><b>Tipo restrictivo:</b> durante los últimos 3 meses la persona no ha incurrido en episodios recurrentes de atracón o conducta purgativa</p> <p><b>Tipo compulsivo/purgativo:</b> durante los últimos 3 meses ha incurrido en episodios recurrentes de atracón o comportamiento purgativo</p> | <p>Episodios recurrentes de atracones. Un episodio de atracón se caracteriza por los dos hechos siguientes</p> <p>Ingestión, en un período determinado (por ejemplo, dentro de un período cualquiera de dos horas), de una cantidad de alimentos que es claramente superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un período similar en circunstancias parecidas</p> <p>Sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio (por ejemplo, sensación de que no se puede dejar de comer o controlar lo que se ingiere o la cantidad de lo que se ingiere)</p> <p>Comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento de peso, como el vómito autoprovocado, el uso incorrecto de laxantes, diuréticos u otros medicamentos, el ayuno o el ejercicio excesivo</p> <p>Los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen, de promedio, al menos una vez a la semana durante tres meses</p> <p>La autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución y el peso corporal</p> <p>La alteración no se produce exclusivamente durante los episodios de anorexia nerviosa</p> <p>En función de la frecuencia de los comportamientos compensatorios inapropiados se puede clasificar en: leve (1-3 episodios a la semana), moderado (4-7 episodios)</p> <p><b>Moderado:</b> un promedio de 4-7 episodios de comportamientos compensatorios inapropiados a la semana</p> <p><b>Grave:</b> un promedio de 8-13 episodios de comportamientos compensatorios inapropiados a la semana</p> <p><b>Extremo:</b> un promedio de 14 episodios de comportamientos compensatorios inapropiados a la semana</p> |

TABLA 2  
Complicaciones médicas de la anorexia nerviosa

| Constitucionales                                 | Gastrointestinales                             |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Caquexia y bajo IMC                              | Gastroparesia (retraso en el vaciado gástrico) |
| Retraso en el crecimiento                        | Estreñimiento                                  |
| Hipotermia                                       | Diarrea                                        |
| Pérdida de masa muscular                         | Dilatación gástrica                            |
| <b>Cardiovasculares</b>                          | Hepatitis                                      |
| Atrofia miocárdica                               | Síndrome de la arteria mesentérica superior    |
| Prolapso mitral                                  | <b>Renales y electrolíticas</b>                |
| Bradicardia                                      | Disminución del filtrado glomerular            |
| Arritmias con riesgo de muerte súbita            | Cálculos renales                               |
| Alargamiento PR                                  | Deshidratación                                 |
| Bloqueo de primer grado                          | Nefropatía hipovolémica                        |
| Alteraciones del ST                              | Hipopotasemia                                  |
| Hipotensión                                      | Hiponatremia                                   |
| Acrocianosis                                     | Hipomagnesemia                                 |
| <b>Ginecológicas y reproductivas</b>             | <b>Hematológicas</b>                           |
| Amenorrea                                        | Anemia                                         |
| Descenso de LH y FSH                             | Leucopenia                                     |
| Embarazo no deseado y complicaciones neonatales  | Trombopenia                                    |
| <b>Endocrinológicas</b>                          | <b>Neurológicas</b>                            |
| Osteoporosis con fracturas de estrés patológicas | Atrofia cerebral                               |
| Síndrome de T3 baja                              | Aumento del tamaño ventricular                 |
| Aumento de GH                                    | Deterioro cognitivo                            |
| Hipercortisolemia                                | Neuropatía periférica                          |
| Hipoglucemia                                     | Convulsiones                                   |
| Diabetes insípida nefrogénica                    | <b>Dermatológicas</b>                          |
| Hipercolesterolemia                              | Xerosis                                        |
| Intolerancia a la glucosa                        | Lanugo                                         |
| <b>Pulmonares</b>                                | Efluvio telógeno                               |
| Pérdida de musculatura pulmonar                  | Carotenodermia                                 |
| Descenso de la capacidad pulmonar                | Cicatrices por conductas autolesivas           |
| Fallo pulmonar                                   | <b>Deficiencias vitamínicas</b>                |
| Neumotórax espontáneo y neumomediastino          | <b>Síndrome de realimentación</b>              |

FSH: hormona foliculoestimulante; GH: hormona del crecimiento; IMC: índice de masa corporal; LH: hormona luteinizante.

jorar la comprensión de este trastorno. Entre ellos, es importante destacar que se elimina el criterio que hacía referencia a la presencia de amenorrea en mujeres pospuberales durante al menos tres ciclos. La eliminación de este criterio tiene que ver con que muchas pacientes no llegaban a presentar amenorrea, a pesar de haber perdido mucho peso y de encontrarse desnutridas, otras no tenían menstruaciones regulares debido a su edad temprana y otras muchas no llegaban a tener menstruación, por lo que era imposible presentar pérdida de ella. Además, este criterio dejaba fuera al género masculino.

Debido a la inanición por la restricción alimentaria o secundaria a las conductas purgativas, pueden aparecer numerosas complicaciones médicas que se recogen en la tabla 2<sup>4</sup>. En todos los pacientes con AN se debe realizar una historia clínica exhaustiva, un examen físico completo y pruebas de laboratorio específicas para evaluar las posibles complicaciones médicas.

## Tratamiento

El tratamiento estándar consiste en la rehabilitación nutricional y la psicoterapia. Este tratamiento puede plantearse en 4 fases:

Fase I: recuperación del equilibrio orgánico y tratamiento de las manifestaciones psicopatológicas.

Fase II: tratamiento de los problemas psicológicos y tratamiento del grupo familiar.

Fase III: reajuste del paciente en su grupo familiar y en su entorno social.

Fase IV: prevención de recaídas y seguimiento de la recuperación alcanzada.

Se recomienda establecer un plan de tratamiento global que incluya el ingreso hospitalario, siempre que haga falta, y una psicoterapia individual y familiar que incluya enfoques cognitivos, conductuales e interpersonales. La decisión de hospitalizar a un paciente se basa en su situación médica y en las infraestructuras necesarias para garantizar la cooperación del paciente. En general, se recomienda que los pacientes cuyo peso esté un 20% por debajo del recomendado para su altura sean hospitalizados.

### Terapia cognitiva conductual

Generalmente incluye rehabilitación nutricional y también aborda pensamientos disfuncionales y comportamientos problemáticos que mantienen el trastorno. Enseña a los pacientes a registrar su ingesta de alimentos, sus sensaciones y sus emociones, sus conductas de atracones y purgativas, y sus problemas con las relaciones interpersonales. También les enseña técnicas de reestructuración cognitiva para identificar pensamientos automáticos.

### Psicoterapia familiar

El ámbito familiar es el primer factor de mantenimiento y uno de los primeros aspectos que debe ser abordado en el tratamiento. En el caso específico de la AN en adolescentes, la terapia familiar se considera el tratamiento de elección<sup>4</sup>.

### Tratamiento farmacológico

Los fármacos no son un tratamiento primario para este trastorno. No obstante, la mayoría de los pacientes con AN tienen síntomas de trastornos depresivos o de trastornos de ansiedad. En la prevención de recaídas, hay evidencia en un ensayo clínico pequeño de que la fluoxetina puede ser útil para prevenir la recaída de los pacientes con AN después de recuperar el peso<sup>11</sup>. El antidepresivo bupropión debe evitarse, porque se asocia con una mayor incidencia de convulsiones en pacientes con trastornos de la alimentación, en particular en pacientes con atracones y purgas. Los antipsicóticos (por ejemplo, olanzapina) o las benzodiazepinas a menudo se usan para reducir los altos niveles de ansiedad asociados con la AN, pero generalmente no se recomiendan para promover el aumento de peso. La quetiapina puede mejorar los síntomas psicológicos, pero hay pocos datos. Como recomendación general, se deben prescribir inicialmente pequeñas dosis, porque los pacientes con bajo peso tienen un mayor riesgo de efectos secundarios. Además, la depleción de proteínas corporales aumenta

el porcentaje de fármaco no ligado (libre) en suero y la depleción de grasa corporal disminuye el volumen de distribución. Los problemas farmacocinéticos, como la absorción deficiente o la toxicidad del fármaco, pueden ocurrir debido a la inanición, los vómitos, la deshidratación o el exceso de hidratación. Los profesionales de la salud deben ser conscientes del riesgo de los medicamentos que prolongan el intervalo QT, dado el riesgo de arritmias secundarias a las alteraciones electrolíticas y las posibles complicaciones cardíacas asociadas con una nutrición inadecuada.

## Evolución y pronóstico

La evolución de la AN es muy variable, desde la recuperación tras la primera línea de tratamiento y la evolución fluctuante de aumentos de peso seguidos de recaídas, hasta la evolución gradualmente degenerativa. En general, la tasa de remisión temprana es relativamente baja, situándose alrededor del 20%-30% al poco tiempo de seguimiento. No obstante, aumenta a casi un 70%-80% después de 8 o más años de seguimiento<sup>12</sup>. Sin embargo, el 10%-20% de los pacientes tienden a la cronicidad.

Las cifras de mortalidad dependen de la gravedad del trastorno, pero se estiman superiores a las de la población general. Las cifras señalan que se encuentra en torno al 5,6% por década<sup>13</sup>. Las muertes suelen ser la consecuencia de complicaciones médicas como la inanición o el desequilibrio electrolítico, así como el suicidio, que se consuma en uno de cada cinco pacientes<sup>14,15</sup>.

Un factor pronóstico favorable es el inicio en edad joven, mientras que los factores de pronóstico desfavorable incluyen tanto la comorbilidad somática como la comorbilidad psiquiátrica<sup>16</sup>. El subtipo restrictivo parece tener una menor probabilidad de recuperación que el subtipo con atracones/purgas.

## Bulimia nerviosa

### Definición

La bulimia nerviosa (BN) se caracteriza por episodios recurrentes de atracones combinados con conductas de compensación inapropiadas destinadas a evitar el aumento de peso. Habitualmente, el malestar físico (por ejemplo: dolor abdominal o náuseas) pone fin al atracón, que a menudo va seguido por sentimientos de culpa. A diferencia de los pacientes con AN, quienes presentan BN suelen mantener un peso normal. Los atracones de comida pueden ser una manera patológica de regulación emocional, también pueden ser secundarios al hambre causado por los esfuerzos por restringir la ingesta o pueden estar motivados por otras causas. En cualquier caso, los atracones generan sentimientos de culpa y miedo intenso a engordar en la persona que los realiza, lo cual le lleva a realizar conductas compensatorias (por ejemplo, vómitos autoinducidos o uso de diuréticos o laxantes) para evitar el temido aumento de peso.

## Epidemiología

La BN es más prevalente que la AN. Las estimaciones de prevalencia oscilan entre el 1% y el 4% en las mujeres jóvenes. Como sucede con la AN, la BN es significativamente más frecuente en las mujeres que en los hombres, pero a menudo su inicio ocurre en etapas más avanzadas de la adolescencia que en la AN. La edad más típica de aparición es entorno a los 20 años<sup>17</sup>. Alrededor del 20% de las mujeres universitarias presentan síntomas bulímicos transitorios en algún momento de sus años de universidad. Aunque la BN se presenta con frecuencia en mujeres jóvenes con un peso normal, en ocasiones existen antecedentes de obesidad.

## Etiología y factores de riesgo

La etiopatogenia de la BN no es completamente conocida, pero sin lugar a duda es multifactorial. Muchos de los estudios que se han realizado hasta el momento son transversales, por lo que no permiten dilucidar si los hallazgos patológicos (por ejemplo, en pruebas de neuroimagen) son causa o consecuencia del trastorno. Se han descrito múltiples genes que pueden contribuir a la etiopatogenia de la enfermedad. De acuerdo con un estudio reciente que ha analizado a más de 780000 participantes, la carga genética puede explicar hasta el 40% de los casos de enfermedad, mientras que el 60% restante se atribuiría a los factores ambientales<sup>18</sup>. Otro factor de riesgo conocido son las experiencias traumáticas en la infancia, especialmente las relacionadas con abuso físico, emocional o cuidado negligente<sup>19</sup>.

## Cuadro clínico y diagnóstico

El diagnóstico de la BN es clínico, por lo que la entrevista clínica es la principal herramienta. Es necesario establecer una buena relación médico/paciente, puesto que algunos pacientes tratarán de ocultar o minimizar la sintomatología. En aquellos pacientes que eludan las preguntas abiertas puede ser necesario realizar preguntas más cerradas, pero evitando que el paciente pueda sentirse juzgado. Si el paciente acude acompañado a la consulta, es fundamental obtener información de su acompañante (con el consentimiento previo del paciente). A su acompañante le debemos preguntar si sospechan la presencia de atracones o de alguna conducta purgativa (si han encontrado laxantes o diuréticos escondidos o algún signo sugestivo de su uso, si han detectado que acude al baño inmediatamente después de comer, si han visto restos de vómitos en el baño, etc.). La entrevista clínica debe ser lo más completa posible y, en cualquier caso, debe incluir al menos la siguiente información:

1. Peso y altura. Es recomendable pesar y tallar a los pacientes en la consulta, así como preguntarles. En caso de encontrar una discordancia relevante entre lo referido por el paciente y lo observado instrumentalmente es bueno abordarlo en la consulta. Evolución del peso a lo largo de la vida, haciendo énfasis en los momentos de mayor y menor peso (circunstancias personales/familiares, posibles estresores,

etc.), fluctuaciones en el peso, patrón de las pérdidas/ganancias de peso (progresivo o rápido) y, por último, saber cuál es el peso deseado.

2. Frecuencia con la que se pesa y monitoriza en su domicilio.

3. Patrón de ingesta cuando no realiza atracones.

4. Síntomas presentes y pasados sugestivos de alteraciones de la conducta alimentaria:

– Restricción dietética.

– Atracones de comida (incluyendo frecuencia, tipos y cantidad de alimentos ingeridos), así como la percepción que el paciente tiene de su grado de control.

– Conductas compensatorias como las conductas purgativas (vómitos autoinducidos, uso de laxantes, diuréticos, enemas o medicamentos semejantes), ayuno prolongado o ejercicio físico excesivo.

– Creencias y actitudes hacia la comida, la imagen corporal o el peso.

– Rituales en relación con la ingesta (por ejemplo: trocear mucho la comida).

– Nivel de autoestima y el grado en que esta se basa en el peso y la imagen corporal.

– Funcionamiento social, familiar y laboral.

– Explorar psicopatología comórbida, poniendo especial énfasis en la presencia de ideación autolítica o intencionalidad suicida.

– Tratamientos psiquiátricos o psicológicos previos.

– Antecedentes familiares psiquiátricos.

Además, es importante hacer una exploración física y solicitar una analítica completa. Algunas alteraciones analíticas (por ejemplo: hipomagnesemia e hiperamilasemia) son sugestivas de conductas purgativas.

En la tabla 1 se recogen los criterios diagnósticos, pero básicamente se debe diagnosticar BN cuando:

1. Los episodios de atracones y las conductas purgativas se producen con relativa frecuencia (al menos 1 vez a la semana) durante por lo menos 3 meses. Los atracones se caracterizan por la ingesta de una elevada cantidad de comida (más de 1000 Kcal) en un breve período de tiempo, acompañada de una sensación de falta de control y de malestar físico (molestias digestivas como pesadez o incluso dolor abdominal). En un estudio en el que participaron 243 participantes con alteraciones de la conducta alimentaria, se encontró que la cantidad de comida consumida durante los episodios de atracón era de 2220 Kcal, aproximadamente (lo cual es equivalente a dos comidas aproximadamente)<sup>20</sup>.

2. Después de los atracones, se practican conductas compensatorias para evitar el aumento de peso, sobre todo mediante la provocación de vómitos y el abuso de laxantes, diuréticos, enemas, eméticos, insulina u hormona tiroidea (80% de los casos) y, con menos frecuencia, dieta estricta y ejercicio extenuante (20% de los casos).

3. La reducción de peso no es tan grave como en la AN.

4. El paciente tiene un miedo patológico a la obesidad, un deseo intenso de delgadez o ambas y, lo que es más importante, una parte desproporcionada de su autovaloración depende del peso y de la imagen corporal.

Al realizar el diagnóstico de BN se debe explorar la existencia de antecedentes de AN, presente en alrededor de la mitad de los pacientes con BN. Es más, la secuencia habitual suele ser: primero, la restricción calórica; segundo, los atracones y, en tercer lugar, la aparición de vómitos autoinducidos. La aparición de atracones suele preceder a la provocación de vómitos en aproximadamente un año. Una vez instaurado el cuadro clínico, la restricción suele precipitar la aparición de atracones y los propios atracones favorecen la aparición de conductas purgativas y períodos más o menos duraderos (desde horas hasta días) de restricción. El DSM-5 clasifica el trastorno como leve (1-3 episodios por semana), moderado (4-7 episodios), grave (8-13 episodios) y extremo (14 o más).

La mayoría de los pacientes con BN se encuentra en un rango de peso normal, pero algunos pueden estar por debajo de él o tener sobrepeso. Estos pacientes están preocupados por su imagen corporal, y se obsesionan por cómo los ven los demás y por su atractivo físico.

## Comorbilidad

Las pacientes con BN con frecuencia presentan comorbilidad psiquiátrica. Es importante diagnosticar la patología comórbida, porque debe tratarse para evitar que afecte negativamente a la evolución. De hecho, la presencia de comorbilidad suele asociarse con una peor evolución. Sin embargo, cuando se logra tratar la BN con éxito, es habitual que las comorbilidades también mejoren o incluso remitan<sup>21</sup>. Las tasas de comorbilidad descritas en pacientes con BN son<sup>22</sup>:

1. Trastornos depresivos: trastorno depresivo mayor unipolar (75%) y distimia (35%).

2. Trastornos de ansiedad: trastorno de ansiedad generalizada (26%); trastorno de pánico (18%); fobia específica (14%) y fobia social (14%).

3. Trastornos por uso de sustancias: problemas relacionados con el alcohol (61%); tabaquismo (43%); otros (30%).

4. Trastorno de estrés postraumático (TEPT) (32%).

5. Trastorno disfórico premenstrual (17%).

6. Trastornos de personalidad (especialmente el trastorno límite de la personalidad) (48%)<sup>22</sup>. Un porcentaje aún mayor de los pacientes con BN presentan rasgos disfuncionales de la personalidad que, aunque no sean los suficientemente graves como para cumplir los criterios diagnósticos de un trastorno de personalidad, sí generan sufrimiento y deterioro del funcionamiento. Estos rasgos disfuncionales de personalidad incluyen: a) impulsividad, caracterizada por actuar sin pensar en las consecuencias y por la incapacidad de resistirse a un estímulo a pesar de ser dañino o perjudicial; b) perfeccionismo, caracterizado por el deseo de cumplir con unos objetivos inalcanzables, a pesar de ser incluso perjudiciales para el sujeto; c) compulsividad, caracterizada por la necesidad de orden, exactitud, simetría y, en último término, la necesidad de control y d) narcisismo, caracterizado por la excesiva preocupación por el aspecto físico y la imagen corporal, la necesidad de admiración y la aprobación de los demás.

## Tratamiento

La mayor parte de los pacientes con BN no necesitan tratamiento en régimen de ingreso hospitalario. En general, el ingreso solo es necesario en aquellos pacientes en los que los atracones y las conductas purgativas están fuera de control (por los desequilibrios electrolíticos o metabólicos), y en aquellos que presentan comorbilidad psiquiátrica grave (ideación suicida o consumo de sustancias). En un metaanálisis que analizó 20 estudios (n mayor de 2100 pacientes), se encontró que hasta un 33% de los pacientes con BN se provocaba en algún momento de la evolución autolesiones o gestos autolíticos sin finalidad suicida (rascados, cortes superficiales, heridas con cigarrillos, etc.)<sup>23</sup>.

### Psicoterapia cognitiva conductual

Debe considerarse el tratamiento principal y de primera línea de la BN. Trata de implementar una serie de intervenciones cognitivas y conductuales para interrumpir el ciclo conductual automantenido de atracón/restricción y modificar los pensamientos disfuncionales del paciente (creencias en torno a la comida, peso, imagen corporal y autoconcepto en general).

### Tratamiento farmacológico

Se ha demostrado que los antidepresivos son útiles para tratar la BN, especialmente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) como la fluoxetina. Los antidepresivos pueden reducir los atracones y las purgas, con independencia de la presencia de un trastorno del estado de ánimo; por lo tanto, se han empleado con buenos resultados para tratar ciclos de vómitos-purgas, en especial los casos complicados que no responden a la psicoterapia sola. Las dosis de fluoxetina que son eficaces para reducir los atracones pueden ser mayores (60-80 mg/día) que las que se emplean para los trastornos depresivos. La carbamazepina y el litio no han mostrado resultados destacables como tratamiento de los atracones.

## Evolución y pronóstico

La BN se caracteriza por tasas más elevadas de recuperación parcial y completa que la AN. Los pacientes tratados tienen una evolución mucho mejor que quienes no reciben tratamiento. Los pacientes no tratados tienden a la cronicidad, aunque pueden mostrar pequeños grados de mejoría, por lo general, poco destacables.

Aunque en la mayoría de los estudios que incluyen seguimiento los participantes son fundamentalmente mujeres, los resultados son comparables a los obtenidos en pacientes hombres. Por ejemplo, en un estudio prospectivo que siguió durante una media de 8 años a 60 mujeres y a 60 hombres, las tasas de remisión obtenidas en las mujeres fueron parecidas a las obtenidas en los hombres (50% y 44%, respectivamente)<sup>24</sup>.

En la mitad de los pacientes aproximadamente (55%), la enfermedad dura al menos 12 meses (3%). En los estudios prospectivos se han encontrado tasas de remisión o recupe-

ración completa del 50%-70%<sup>25,26</sup>. Las probabilidades de recuperación disminuyen si esta no se logra en la primera década de seguimiento<sup>26,27</sup>. El trastorno por uso de sustancias comórbido se asocia con un peor pronóstico, así como la mayor intensidad de los síntomas<sup>25</sup>. Aproximadamente, un 20%-30% de los pacientes que se recuperan sufren una recaída<sup>26,28</sup>. Los predictores de recaída son: sintomatología basal más intensa (antes de iniciar el tratamiento), mayor frecuencia de atracones, vómitos autoinducidos o la presencia de insatisfacción con la imagen corporal (por ejemplo, evitar mirarse en el espejo o vestir con prendas amplias que impidan que se marque el cuerpo)<sup>25,28</sup>.

A pesar de que la BN incluye el miedo intenso a ganar peso, la mayoría de las pacientes a medio-largo plazo tienen un peso comprendido dentro de la normalidad. En un estudio prospectivo que incluyó 22 años de seguimiento, se encontró que la mayoría de los pacientes que se habían recuperado presentaban un índice de masa corporal (IMC) normal (67%)<sup>29</sup>. Este porcentaje fue ligeramente mayor en el grupo de pacientes que no habían logrado recuperarse (74%). Las pacientes de ambos grupos que no presentaban un IMC dentro de la normalidad presentaban sobrepeso u obesidad.

La BN se asocia a mayores tasas de autolesiones, intentos de suicidio y suicidio consumado que la población general. Sin embargo, las tasas de suicidio de estas pacientes son significativamente menores al comunicado en pacientes que presentan trastorno bipolar, depresión o esquizofrenia.

### Intentos de suicidio

Se estima que entre el 20%-30% de los pacientes con BN realiza un intento de suicidio (de mayor o menor letalidad) en algún momento de la evolución. En comparación con la población general, estos pacientes presentan un riesgo 2-6 veces mayor de suicidio<sup>30-32</sup>. Los factores de riesgo para realizar un intento autolítico son: a) comorbilidad psiquiátrica (por ejemplo, depresión, trastorno de personalidad, trastorno por uso de sustancias, etc.); b) necesidad de hospitalización; c) antecedentes de autolesión previos al diagnóstico de la enfermedad; d) mayor tiempo de evolución de la enfermedad; e) escasa capacidad de regulación emocional y f) tener un familiar de primer grado con trastorno de la conducta alimentaria.

### Suicidio consumado

Las muertes por suicidio son entre 4 y 7 veces más frecuentes en los pacientes con BN que en la población general<sup>33,34</sup>.

## Trastorno por atracón

El trastorno por atracón (TPA) tiene una prevalencia del 1,9%-3%<sup>35</sup>. La sintomatología se caracteriza por episodios de atracones recurrentes (1 o más por semana durante 3 meses), breves (menos de 2 horas) caracterizados por una marcada angustia, durante los cuales los pacientes sienten que tienen una completa falta de control sobre la ingesta, y donde consumen mayores cantidades de alimentos que la mayoría de las personas en circunstancias similares. El TPA es más común en mujeres (3,5%) que en hombres (2,0%), así como

en individuos obesos<sup>36</sup>. Sin embargo, las tasas de prevalencia no parecen asociarse con la etnia, el estado civil o la situación laboral. La mediana de edad de inicio del TPA suele darse aproximadamente alrededor de los 23 años<sup>35</sup>.

En la última versión del DSM-5, se reconoció oficialmente la existencia del TPA como entidad propia, mientras que en versiones anteriores figuraba como un trastorno de la alimentación no especificado (TCANE)<sup>5</sup>. El diagnóstico del DSM-5 de TPA requiere la presencia de atracones, definidos como el consumo en un corto período de tiempo de una mayor cantidad de alimentos que la que comerían otras personas en las mismas circunstancias. El factor clave de estos episodios es la sensación de falta de control sobre la ingesta (bien por cantidad o por imposibilidad para parar). Además, estos episodios de atracones se caracterizan por, al menos, tres de los siguientes:

1. Comer más rápido de lo normal.
2. Comer hasta sentirse lleno.
3. Comer grandes cantidades de comida, aun cuando no se tiene hambre.
4. Comer a solas por la vergüenza que le produce ingerir tal cantidad de comida.
5. Sentirse disgustado con uno mismo, deprimido o culpable después de comer en exceso.

Los episodios ocurren, en promedio, al menos una vez a la semana durante tres meses y no suele haber conductas compensatorias inapropiadas como las que se dan en otros TCA.

Aunque el TPA se consideró inicialmente un trastorno de la edad adulta, cada vez hay más evidencia de que comienza en la adolescencia, con una edad promedio de inicio que va desde finales de la adolescencia hasta principios de los 20 años y una persistencia media de 4,3 años<sup>37</sup>. Marcus y Kalarichian propusieron unos criterios diferentes para el TPA en adolescentes, en el que primara la sensación de pérdida de control, entendida como la búsqueda de alimentos en ausencia de hambre o el uso de la comida como regulador emocional<sup>38</sup>.

El TPA se asocia con un peor bienestar psicológico y físico<sup>36</sup>. En la tabla 3 aparecen descritas las principales comorbilidades y complicaciones del mismo<sup>36</sup>. Es importante destacar que, al igual que otros TCA, los pacientes con TPA muestran un grado de alexitimia relevante y un déficit en la identificación y regulación emocional, así como una alta tasa de problemática interpersonal<sup>37</sup>. Otras características psicopatológicas relevantes son las siguientes<sup>38</sup>:

1. La sobrevaloración de la forma y el peso corporal: presente en el 60% de los pacientes con TPA, y se relaciona con un peor control de la alimentación, un mayor miedo a aumentar de peso y una mayor insatisfacción con la forma del cuerpo que las personas obesas sin TPA. Este factor podría considerarse un especificador para el diagnóstico, así como un objetivo específico para las terapias psicológicas.
2. Regulación emocional: se ha planteado que los atracones sean una estrategia desadaptativa que intente regular las emociones negativas.
3. Comportamientos alimentarios atípicos: entre ellos se incluyen la restricción dietética o comer poco por la mañana,

TABLA 3

**Comorbilidades y complicaciones más frecuentes del trastorno por atracón**

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Comorbilidades psiquiátricas | Fobia específica (37%)                                   |
|                              | Fobia social (32%)                                       |
|                              | Trastorno depresivo mayor (32%)                          |
|                              | Trastorno de estrés postraumático (26%)                  |
|                              | Trastorno por consumo de alcohol (21%)                   |
|                              | Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (20%) |
|                              | Trastorno evitativo de la personalidad (12%)             |
|                              | Trastorno límite de la personalidad (10%)                |
| Comorbilidades médicas       | Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad (10%)   |
|                              | Obesidad (50%)                                           |
|                              | Hipertensión                                             |
|                              | Síndrome metabólico                                      |
|                              | Dolor crónico                                            |
| Otros                        | Síndrome de intestino irritable                          |
|                              | Diabetes mellitus                                        |
|                              | Angustia en las relaciones                               |
|                              | Deterioro del funcionamiento psicosocial                 |

o patrones recurrentes de comer en exceso, como hacer comidas dobles o comer en exceso por la noche.

4. Patrón adictivo hacia la comida: existe un aumento de la sensibilidad a la recompensa de la comida, configurando así un fenotipo de obesidad con aumento de la impulsividad.

El objetivo del tratamiento del TPA es reducir la frecuencia de los episodios de atracones y los trastornos cognitivos relacionados con la alimentación, mejorar la salud metabólica y el peso y regular el estado de ánimo. Antes de iniciar el tratamiento, es recomendable realizar una evaluación integral del paciente que incluya el estado físico, mental y nutricional<sup>39</sup>. Los enfoques de tratamiento incluyen el tratamiento farmacológico, el tratamiento psicológico y el tratamiento combinado de ambas modalidades. Las guías clínicas actuales respaldan el uso de la terapia cognitiva conductual, tanto en formato individual como grupal, desaconsejando el uso de ISRS como única opción terapéutica. La psicoterapia interpersonal y la terapia dialéctica conductual también han demostrado eficacia. La terapia farmacológica en el TPA se centra en la reducción de la impulsividad alimentaria, los atracones y los sentimientos negativos<sup>37</sup>. Los antidepresivos son los medicamentos más utilizados en el tratamiento del TPA, mostrando eficacia sobre la impulsividad alimentaria y la psicopatología, además de mejorar la ansiedad y los síntomas depresivos<sup>37</sup>. También se han empleado fármacos antiepilépticos (como el topiramato y zonisamida) y medicamentos indicados para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (como la atomoxetina y la lisdexanfetamina)<sup>37</sup>.

## Responsabilidades éticas

**Protección de personas y animales.** Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

**Confidencialidad de los datos.** Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

**Derecho a la privacidad y consentimiento informado.** Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

## Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

## Bibliografía

● Importante ●● Muy importante

✓ Metaanálisis      ✓ Artículo de revisión  
✓ Ensayo clínico controlado      ✓ Guía de práctica clínica  
✓ Epidemiología

1. ● Bravender T, Bryant-Waugh R, Herzog D, Katzman D, Kreipe RD, Lask B, et al. Classification of child and adolescent eating disturbances. *Int J Eat Disord.* 2007;40(S3):S117-22.
2. ● Becker AE. Culture and eating disorders classification. *Int J Eat Disord.* 2007;40(S3):S111-6.
3. ● Fairburn CG, Cooper Z, Doll HA, Welch SL. Risk factors for anorexia nervosa. *Arch Gen Psychiatry.* 1999;56(5):468-76.
4. ● Morandé Lavín G, Graell Berna M BFM. Trastornos de la conducta alimentaria y obesidad. Un enfoque integral. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2014.
5. ● Galmiche M, Déchelotte P, Lambert G, Tavolacci MP. Prevalence of eating disorders over the 2000–2018 period: a systematic literature review. *Am J Clin Nutr.* 2019;109(5):1402-13.
6. ●● American Psychiatric Association - APA. Manual Diagnóstico y Estadístico de Los Trastornos Mentales DSM-5. 5ª. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2014.
7. ● Bermúdez Durán LV, Chacón Segura MA, Rojas Sancho DM. Actualización en trastornos de conducta alimentaria: anorexia y bulimia nerviosa. *Rev Medica Sinerg.* 2021;6(8):e753.
8. ● Buitrago Ramírez F, Ciurana Misol R, Chocrón Bentata L, Carmen Fernández Alonso M del, García Campayo J, Montón Franco C, et al. Prevención de los trastornos de la salud mental en atención primaria. Actualización PAPPs 2018. Atención Primaria. 2018;50:83-108.
9. ● Gómez Candela C. Consenso sobre la evaluación y el tratamiento nutricional de los trastornos de la conducta alimentaria: anorexia nerviosa. *Nutr Hosp.* 2017;34(5):489-94.
10. ●● Organización Mundial de la Salud (OMS). CIE-10. Trastornos mentales y del comportamiento. Décima revisión de la clasificación internacional de las enfermedades. Descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico. 1992.
11. ●● Walsh BT, Kaplan AS, Attia E, Olmsted M, Parides M, Carter JC, et al. Fluoxetine after weight restoration in anorexia nervosa. *JAMA.* 2006;295(22):2605-12.
12. ● Keel PK, Brown TA. Update on course and outcome in eating disorders. *Int J Eat Disord.* 2010;43(3):195-204.
13. ● Grave RD. Eating disorders: Progress and challenges. *Eur J Intern Med.* 2011;22(2):153-60.
14. ● Hoek HW. Incidence, prevalence and mortality of anorexia nervosa and other eating disorders. *Curr Opin Psychiatry.* 2006;19(4):389-94.
15. ● Birmingham CL, Su J, Hlynsky JA, Goldner EM, Gao M. The mortality rate from anorexia nervosa. *Int J Eat Disord.* 2005;38(2):143-6.
16. ●● Papadopoulos FC, Ekblom A, Brandt L, Ekselius L. Excess mortality, causes of death and prognostic factors in anorexia nervosa. *Br J Psychiatry.* 2009;194(1):10-7.
17. ● Udo T, Grilo CM. Prevalence and correlates of DSM-5-defined eating disorders in a nationally representative sample of U.S. Adults. *Biol Psychiatry.* 2018;84(5):345-54.
18. ●● Yao S, Larsson H, Norring C, Birgegård A, Lichtenstein P, D'Onofrio BM, et al. Genetic and environmental contributions to diagnostic fluctuation in anorexia nervosa and bulimia nervosa. *Psychol Med.* 2021;51(1):62-9.
19. ●● Afifi TO, Sareen J, Fortier J, Taillieu T, Turner S, Cheung K, et al. Child maltreatment and eating disorders among men and women in adulthood: Results from a nationally representative United States sample. *Int J Eat Disord.* 2017;50(11):1281-96.
20. ● Forney KJ, Bodell LP, Haedt-Matt AA, Keel PK. Incremental validity of the episode size criterion in binge-eating definitions: An examination in women with purging syndromes. *Int J Eat Disord.* 2016;49(7):651-62.
21. ● Fichter MM, Quadflieg N, Hedlund S. Long-term course of binge eating disorder and bulimia nervosa: Relevance for nosology and diagnostic criteria. *Int J Eat Disord.* 2008;41(7):577-86.
22. ● Udo T, Grilo CM. Psychiatric and medical correlates of DSM-5 eating disorders in a nationally representative sample of adults in the United States. *Int J Eat Disord.* 2019;52(1):42-50.
23. ●● Cucchi A, Ryan D, Konstantakopoulos G, Stroumpa S, Kaçar AŞ, Renshaw S, et al. Lifetime prevalence of non-suicidal self-injury in patients with eating disorders: a systematic review and meta-analysis. *Psychol Med.* 2016;46(7):1345-58.
24. ●● Strobel C, Quadflieg N, Naab S, Voderholzer U, Fichter MM. Long-term outcomes in treated males with anorexia nervosa and bulimia nervosa—A prospective, gender-matched study. *Int J Eat Disord.* 2019;52(12):1353-64.
25. ● Castellini G, Lo Sauro C, Mannucci E, Raval di C, Rotella CM, et al. Diagnostic crossover and outcome predictors in eating disorders according to DSM-IV and DSM-V proposed criteria: A 6-year follow-up study. *Psychosom Med.* 2011;73(3):270-9.
26. ● Eddy KT, Tabri N, Thomas JJ, Murray HB, Keshaviah A, Hastings E, et al. recovery from anorexia nervosa and bulimia nervosa at 22-year follow-up. *J Clin Psychiatry.* 2017;78(02):184-9.
27. ●● Franko DL, Tabri N, Keshaviah A, Murray HB, Herzog DB, Thomas JJ, et al. Predictors of long-term recovery in anorexia nervosa and bulimia nervosa: Data from a 22-year longitudinal study. *J Psychiatr Res.* 2018;96:183-8.
28. ●● Olmsted MP, MacDonald DE, McFarlane T, Trotter K, Colton P. Predictors of rapid relapse in bulimia nervosa. *Int J Eat Disord.* 2015;48(3):337-40.
29. ●● Murray HB, Tabri N, Thomas JJ, Herzog DB, Franko DL, Eddy KT. Will I get fat? 22-year weight trajectories of individuals with eating disorders. *Int J Eat Disord.* 2017;50(7):739-47.
30. ●● Mandelli L, Arminio A, Atti A-R, De Ronchi D. Suicide attempts in eating disorder subtypes: a meta-analysis of the literature employing DSM-IV, DSM-5, or ICD-10 diagnostic criteria. *Psychol Med.* 2019;49(8):1237-49.
31. ●● Yao S, Kuja-Halkola R, Thornton LM, Runfola CD, D'Onofrio BM, Almqvist C, et al. Familial liability for eating disorders and suicide attempts. *JAMA Psychiatry.* 2016;73(3):284.
32. ●● Udo T, Bitley S, Grilo CM. Suicide attempts in US adults with lifetime DSM-5 eating disorders. *BMC Med.* 2019;17(1):120.
33. ●● Hoang U, Goldacre M, James A. Mortality following hospital discharge with a diagnosis of eating disorder: National record linkage study, England, 2001–2009. *Int J Eat Disord.* 2014;47(5):507-15.
34. ●● Suokas JT, Suvisaari JM, Gissler M, Löfman R, Linna MS, Raevuori A, et al. Mortality in eating disorders: A follow-up study of adult eating disorder patients treated in tertiary care, 1995–2010. *Psychiatry Res.* 2013;210(3):1101-6.
35. ● Kessler RC, Berglund PA, Chiu WT, Deitz AC, Hudson JI, Shahly V, et al. The Prevalence and correlates of binge eating disorder in the World Health Organization World Mental Health Surveys. *Biol Psychiatry.* 2013;73(9):904-14.
36. ●● Brownley KA, Berkman ND, Peat CM, Lohr KN, Cullen KE, Bann CM, et al. Binge-eating disorder in adults. *Ann Intern Med.* 2016;165(6):409.
37. ● Amianto F, Ottone L, Abbate Daga G, Fassino S. Binge-eating disorder diagnosis and treatment: a recap in front of DSM-5. *BMC Psychiatry.* 2015;15(1):70.
38. ● Dingemans A, Danner U, Parks M. Emotion regulation in binge eating disorder: A review. *Nutrients.* 2017;9(11):1274.
39. ● Marcus MD, Kalarchian MA. Binge eating in children and adolescents. *Int J Eat Disord.* 2003;34(S1):S47-57.